

返院一周综合报告

生成时间：2026-05-18 16:07:58

返院一周综合报告

长者姓名：陈萍忠

年龄：68岁

诊断：阿尔茨海默病性痴呆、心脏起搏器植入术后、胆囊切除术后

报告时间范围：返院后第1日至第7日（D1 - D7）

一、BPSD事件频次趋势

返院一周内共记录**1次轻微BPSD事件**（发生于返院第3日），表现为拒绝配合康复训练，无言语攻击、肢体冲突或其他过激行为。此后连续4日无任何BPSD事件复发，症状呈**持续缓解趋势**。NPI评分稳定在15分左右，较住院前显著改善。

二、事件时段分布

唯一BPSD事件发生于**上午10:00 - 11:00活动时段**，与日常康复训练安排时间重合，提示该时段可能存在认知负荷或环境刺激敏感性。

三、干预有效率

针对BPSD事件，照护团队严格依据专项任务包执行干预措施，包括：

- 结合老人喜好（跳舞）进行话题安抚；
- 灵活调整康复训练形式（如改用播放熟悉舞曲、引导简易舞步）。

干预后老人情绪迅速缓解，当日后续活动配合良好，且**未再出现类似事件**。本周BPSD干预有效率为**100%（1/1）**。

四、药物调整情况

本周内**未进行任何药物调整**。老人每日规律服用降压药、调脂药及认知障碍相关药物（如多奈哌齐、美金刚等），无漏服、错服或药物不良反应报告。

五、高风险行为摘要

本周**未发生**跌倒、走失、自伤、攻击行为、外伤或急性躯体事件。跌倒防护措施落实到位，环境安全监控有效。

六、当前关键问题

1. **血脂控制未达标**：返院D7总胆固醇为6.0 mmol/L（高于理想目标值5.2

mmol/L)，提示当前降脂方案效果有限，需评估是否需调整用药或生活方式干预。

2. ****康复依从性仍需巩固****：尽管通过兴趣引导提升参与度，但老人对结构化康复训练仍存在潜在抵触，需持续优化非药物干预策略。

3. ****家属焦虑未完全消除****：家属虽经2次专业指导后照护信心提升，但仍对BPSD复发表示担忧，需加强心理支持与复发应对能力建设。

七、需决策事项

1. 是否调整降脂治疗方案以进一步控制总胆固醇水平？
2. 是否将“ 舞曲引导式认知干预 ”纳入标准化照护路径，并评估其长期效果？
3. 是否为家属提供BPSD复发早期识别工具包及应急处理演练？

八、会诊建议问题清单（供精神科参考）

1. 当前BPSD症状稳定（NPI≈15），是否可逐步减少抗精神病药物（如奥氮平）剂量或维持现有方案？
2. 针对“ 活动时段拒绝训练 ”这一特定情境，有哪些循证非药物干预策略可进一步强化？
3. 如何建立个体化的BPSD复发预警指标（如睡眠变化、离床频率、情绪波动）？
4. 家属持续焦虑是否需引入家庭心理支持或照护者赋能项目？

****总结****：陈萍忠老人返院一周整体状态良好，BPSD症状显著缓解，照护执行规范，生理指标平稳，无安全事件。后续重点在于巩固非药物干预效果、优化慢病管理（尤其血脂）、并加强家属支持体系，以预防症状复发，促进长期功能维持。